TRANSPORT FRANCO GARDA / MONO ROUE / BARRES PORTAGE

DESCRIPTION

PLIAGE ET PORTAGE BRANCARD

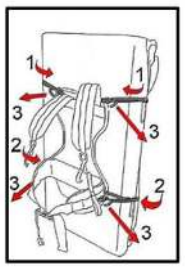
1. Harnais de portage :

Un harnais de portage est disponible pour porter le brancard en position repliée. Le brancard peut ainsi être porté sur le dos.

Installation du harnais de portage :

- Passez les sangles hautes dans les poignées supérieures du brancard. La tête du brancard doit être orientée vers le haut (1).
- Passez les sangles basses dans les poignées inférieures de la coque centrale (2).
- Serrez les 4 sangles en répartissant bien la tension entre la droite et la gauche (3).

Note : le système de portage pédestre 9.4.7 est équipé de deux de ces harnais.







PORTAGE ROUE





PORTAGE ROUE + HAMPES



UTILISER LES SANGLES EN PLUS PAS LES SANGLES ELASTIQUES DU SUPPORT DE ROUE



FICHE TECHNIQUE EMPLOI

Montage Démontage FRANCO GARDA

SMPM 84

DESCRIPTION

1/ OUVERTURE PARTIE AVANT

1.1



1.3



1.2

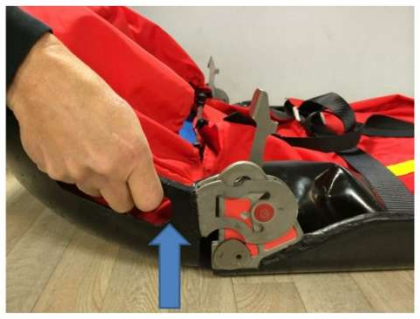


2/ FERMETURE PARTIE AVANT

2.1



2.3



2.2



2.4



3/ OUVERTURE PARTIE ARRIERE

3.1



3.3



3.5



3.2



3.4



4/ FERMETURE PARTIE ARRIERE

4.1



4.3



4.5



4.6



4.2



4.4



4.6



4.8



Conditionnement victime FRANCO GARDA / Utilisation pantoire

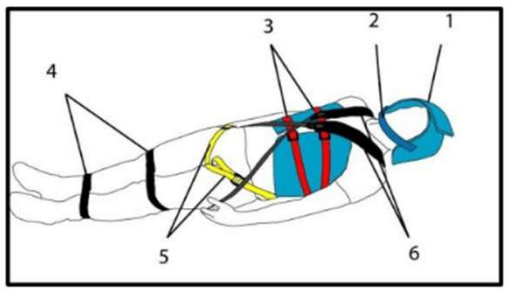
DESCRIPTION

1. Mise en place du patient dans la housse :

1. Immobilisation (Figure 28) :

- Placer le blessé dans la housse, **le plus haut possible** .
- Ajuster la têtière pour maintenir au mieux la tête (1).
- Placer la mentonnière (2).
- Placer et fermer les volets de maintien thorax (3).
- Fermer et ajuster les sangles de maintien « culotte » (5).
- Fermer les bretelles et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (6).
- Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4), les positionner sur la daisy chaine centrale selon la taille de la personne.

Figure 28



2. Ajustement de la longueur de la housse :

Si le patient est un enfant ou une personne de petite taille, la sangle de pied permet d'ajuster la longueur de la housse (Figure 29).

3. Fermeture de la capote :

La capote peut être maintenue ouverte ou fermée par des sangles (Figures 30 et 31).



Figure 29



Figure 30



Figure 31

9.1.4 Volets d'accès et poches : (voir figure 7 page 6)

La housse est munie d'accès direct aux membres supérieurs (7) et inférieurs (5) du blessé. La poche inférieure permet la visualisation d'une bouteille d'oxygène ou des appareils placés au niveau des jambes du blessé (5). Une poche sur le dessus de la housse permet le transport de documents concernant le blessé (6).

1. Immobilisation à l'intérieur de la housse :

- Mettre à plat la têtière.
- Placer le patient et le matelas à dépression dans la housse.
- Placer et fermer les volets de maintien thorax (2).
- Fermer en croisant les sangles de maintien « culotte » et serrer (3).
- Fermer les bretelles et ajuster la tension de manière à ce que le blessé soit maintenu fermement (1).
- Maintenir les jambes avec les deux sangles de maintien (4).

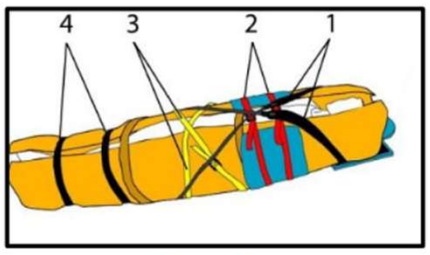


Figure 32

1. Fermeture de la housse :

- Rabattre précisément les deux volets extérieurs de la housse.
- Fermer correctement les quatre sangles extérieures

Ajuster la tension de chaque sangle pour immobiliser complètement le blessé.

- **Pour un treuillage contre une paroi ou tout autre obstacle, l'ouverture des mousquetons doit être orientée vers l'intérieur du brancard (Figure 6).**



Figure 6

- **Les sangles des brins ne doivent pas être vrillées, ni faire de nœud (Figure 7).**



Figure 7

- **Le maillon delta central doit être correctement fermé (Figure 8).**

  Couple de serrage : 7(N.m)



Figure 8

- **Ne pas accrocher de charge supplémentaire sur le maillon delta central, ni sur les mousquetons, ni sur les sangles (Figures 9; 10 et 11).**



Figure 9



Figure 10

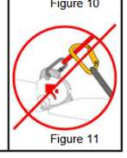


Figure 11

- Les brins rouges de la pantoire doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulation avants repérées en rouge sur le brancard (Figures 3 et 4).

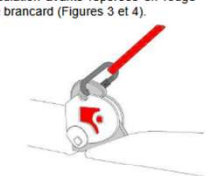
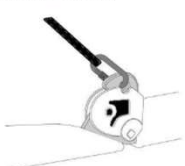


Figure 4

- Les brins noir de la pantoire doivent être mousquetonnés sur les pattes d'articulation arrières repérées en noir sur le brancard (Figures 3 et 5).



- **Réglage arrière long (Figure 14) :**

Le mousqueton est placé sur la boucle arrière à 650 mm pour une taille de la victime inférieure à 1m75 ou si le poids est concentré sur l'avant du brancard (par exemple pour une personne de très petite taille).

- **Réglage arrière court (Figure 15) :**

Le mousqueton est placé sur la boucle arrière à 600 mm pour une taille supérieur à 1m75 ou si le poids est concentré sur l'arrière du brancard (par exemple avec le rajout d'une bouteille d'oxygène).

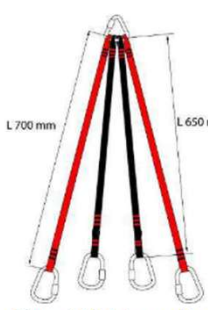


Figure 14 Réglage arrière long

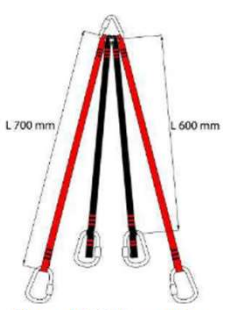


Figure 15 Réglage arrière court

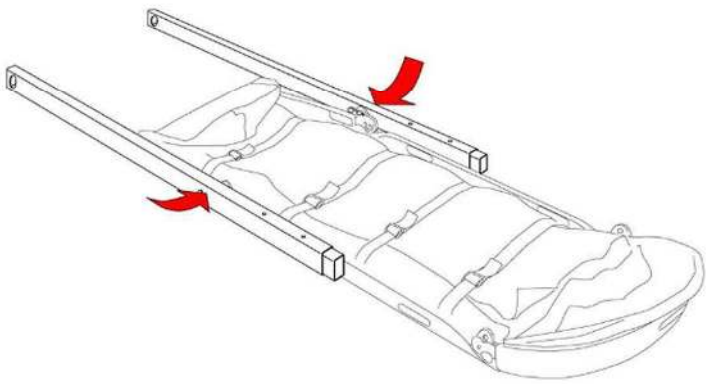


Utilisation bras portage et mono-roue FRANCO GARDA

DESCRIPTION

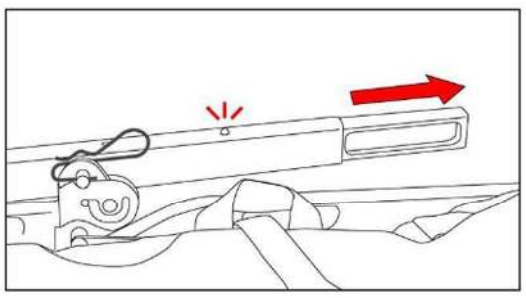
MONTAGE BRAS DE PORTAGE

1- Fixer les tubes arrière (peinture noire) sur les articulations arrière du brancard (repérées en noir).

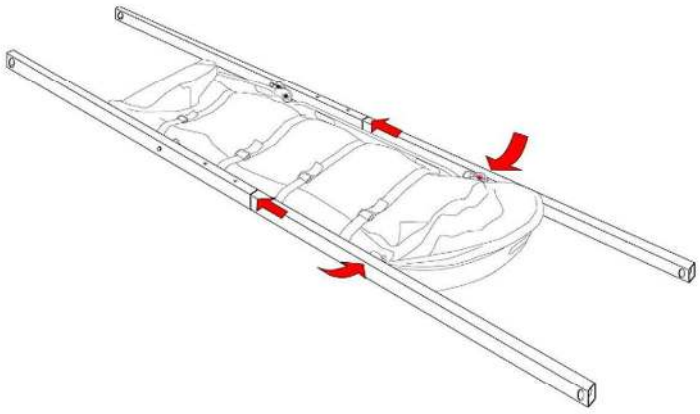


2- Mettre en position les goupilles pour verrouiller les bras.

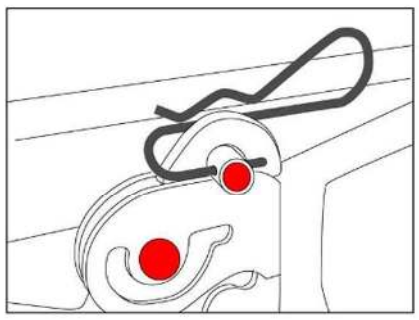
3- Sortir les manchons jusqu'au verrouillage par les snaps.



4- Insérer les tubes avant (peinture rouge) sur les manchons et verrouiller les goupilles sur les articulations avant du brancard (repérées en rouge).



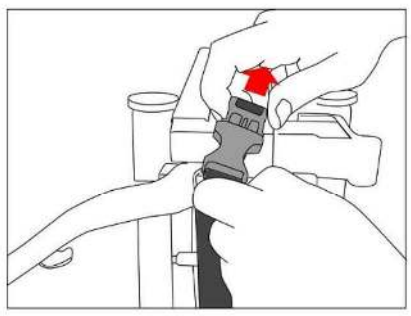
Il est important de bien s'assurer de la bonne mise en place des goupilles de verrouillage avant de commencer la descente.



MONTAGE MONO-ROUE

a) Ouvrir les boucles plastiques de blocage des équerres de fixation.





b) Déplier les équerres de fixation et les verrouiller à l'aide des boutons snaps.



c) Soulever doucement le brancard avec le patient jusqu'à ce que la roue passe sous ce dernier. Reposer le brancard sur la roue, puis verrouiller les crochets.



3/ Utilisation :

Lors de l'utilisation, le sens de marche doit correspondre à celui indiqué sur le sticker.



Attention : bien vérifier la pression du pneu avant l'utilisation. (0,5 bars)